

Insuficiencia venosa crónica (IVC)

1. Introducción y relevancia clínica

La **insuficiencia venosa crónica (IVC)** corresponde al **trastorno del retorno venoso de las extremidades inferiores**, debido a **disfunción valvular** y/o **obstrucción venosa**, lo que produce **aumento sostenido de la presión venosa** (hipertensión venosa) y, como consecuencia, alteraciones tróficas en piel, tejido subcutáneo y sistema venoso superficial.

Importancia clínica

- Afecta al **25–30% de la población adulta**.
 - Es más frecuente en **mujeres** y en personas con **antecedentes familiares de varices**.
 - En Chile, es una de las **principales causas de consulta vascular** en atención primaria.
 - Puede evolucionar a **úlceras venosas crónicas**, responsables del 70–80% de las úlceras de pierna.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

2.1 Fisiología venosa normal

El retorno venoso desde las extremidades inferiores depende de:

- **Válvulas venosas competentes**, que permiten flujo unidireccional hacia el corazón.
 - **Bomba muscular de la pantorrilla**, que impulsa la sangre venosa durante la marcha.
 - **Presión negativa intratorácica** que facilita el ascenso sanguíneo.
-

2.2 Mecanismo fisiopatológico

La IVC ocurre cuando existe **incompetencia valvular** o **obstrucción venosa**, lo que provoca **reflujo retrógrado** y **aumento de la presión venosa distal**.

Este aumento crónico de presión:

- Incrementa la permeabilidad capilar.
- Favorece extravasación de proteínas y glóbulos rojos.
- Induce inflamación, fibrosis y alteraciones cutáneas.

2.3 Clasificación anatómica y funcional (CEAP 2022)

Categoría	Descripción
C – Clínica	C0: sin signos visibles o palpables C1: telangiectasias o venas reticulares C2: varices C3: edema C4a: pigmentación o eczema C4b: lipodermatoesclerosis o atrofia blanca C5: úlcera cicatrizada C6: úlcera activa
E – Etiología	Congénita, primaria o secundaria (postrombótica)
A – Anatomía	Superficial, profunda o perforante
P – Fisiopatología	Reflujo, obstrucción o ambos

☐ En práctica clínica, el **C3–C6** se considera IVC clínicamente significativa.

2.4 Causas más frecuentes

Tipo	Ejemplos
Primaria	Degeneración valvular idiopática (varices primarias)

Secundaria Síndrome postrombótico (tras TVP), compresión extrínseca, malformaciones venosas

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1 Síntomas típicos

- **Pesadez o cansancio** de piernas (empeora al final del día).
 - **Dolor o calambres** vespertinos o nocturnos.
 - **Edema maleolar** (inicialmente vespertino, luego persistente).
 - **Prurito o sensación de calor**.
 - **Alivio al elevar las piernas o con la marcha**.
-

3.2 Signos clínicos

Hallazgo	Descripción
Varices visibles	Dilataciones tortuosas del sistema venoso superficial
Edema crónico blando	Generalmente en región maleolar
Hipodermitis o eczema venoso	Piel eritematosa, descamativa, pruriginosa
Hiperpigmentación ocre	Por extravasación de hemosiderina

Lipodermatoesclerosis	Engrosamiento y retracción cutánea (en “botella de champaña invertida”)
Úlcera venosa	Placa húmeda, superficial, bordes irregulares, localizada en región maleolar interna
☐ Diferenciar con úlceras arteriales (dolorosas, secas, con pulsos ausentes y localización distal).	

3.3 Diagnóstico diferencial

Patología	Características distintivas
Insuficiencia cardíaca	Edema bilateral con ortopnea, sin cambios cutáneos
Insuficiencia renal / hepática	Edema blando, generalizado
Linfedema	Edema duro, no depresible, piel engrosada
Úlcera arterial	Dolor intensa, bordes definidos, piel fría y pálida
Úlcera neuropática (diabética)	Indolora, en zonas de presión plantar, piel seca

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

4.1 Diagnóstico clínico

En la mayoría de los casos, la **IVC es un diagnóstico clínico** basado en la anamnesis y el examen físico (CEAP $\geq$ C2).

Sin embargo, el **Doppler venoso** es fundamental para:

- Confirmar la presencia de reflujo u obstrucción.
 - Mapear el sistema venoso superficial y profundo.
 - Planificar tratamiento quirúrgico o endovascular.
-

4.2 Ecografía Doppler venosa

Examen de elección.

Evalúa:

- Competencia valvular del sistema superficial (vena safena interna y externa).
- Reflujo retrógrado (>0,5 segundos).
- Presencia de trombosis o alteraciones postrombóticas.

En Chile, el **Doppler color venoso bilateral** es parte del protocolo previo a cirugía de varices.

4.3 Otros exámenes

- **Pletismografía venosa:** cuantifica el volumen venoso y el reflujo.
 - **Venografía:** se reserva para casos complejos o reintervenciones.
 - **Úlceras crónicas:** cultivo bacteriano y biopsia si no cicatrizan (descartar neoplasia o vasculitis).
-

5. Tratamiento (según guías MINSAL, Sociedad Chilena de Flebología y NICE 2023)

5.1 Objetivos

1. Mejorar síntomas y calidad de vida.
2. Prevenir progresión de daño tisular.

3. Promover cicatrización de úlceras.
4. Reducir recurrencia y complicaciones.

5.2 Medidas generales

- **Elevación de las piernas** (30 cm) varias veces al día.
- **Ejercicio físico regular**: caminar activa la bomba muscular.
- Evitar ortostatismo o sedentarismo prolongado.
- Control de peso.
- Suspender tabaco.

5.3 Terapia compresiva (base del tratamiento)

- **Medias elásticas de compresión graduada (30–40 mmHg)** desde el pie hasta el muslo o rodilla.
- Indicadas en todos los grados $\geq C2$ (si no hay arteriopatía significativa).
- Favorecen el retorno venoso, reducen edema y aceleran cicatrización de úlceras.
- En úlceras: usar **vendajes multicapa de compresión**.

Contraindicadas si ITB $< 0,8$ (enfermedad arterial periférica asociada).

5.4 Tratamiento farmacológico

Grupo	Ejemplo	Utilidad
Flebotónicos / vasoprotectores	Diosmina, hesperidina, dobesilato cálcico	Mejoran síntomas subjetivos, edema y dolor

Antiinflamatorios tópicos o sistémicos	Ibuprofeno, diclofenaco	Alivian dolor e inflamación local
Antibióticos tópicos o sistémicos	Según cultivo	En úlceras infectadas
Anticoagulación	Si coexistencia de TVP o tromboflebitis	Profilaxis o tratamiento específico

5.5 Tratamiento quirúrgico y endovascular

Técnica	Indicaciones	Descripción
Safenectomía (stripping)	Reflujo de safena interna o externa	Ligadura y extracción venosa completa
Ablación endovenosa con láser o radiofrecuencia	Varices tronculares	Técnica mínimamente invasiva, reemplaza la safenectomía clásica
Escleroterapia	Telangiectasias o varices pequeñas	Inyección de esclerosante (polidocanol)
Cirugía perforante (SEPS)	Insuficiencia perforante profunda	Abordaje subfascial endoscópico
Tratamiento de úlceras venosas	Curas avanzadas + compresión + eventual injerto cutáneo	Multidisciplinario

5.6 Manejo de úlceras venosas

- Limpieza con suero fisiológico (no antisépticos).
 - Curas húmedas con apósitos hidrocoloides o de plata.
 - Antibióticos solo si signos de infección.
 - Vendaje compresivo multilámina.
 - Derivación a cirugía vascular si no hay respuesta en 6–8 semanas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

Complicación	Descripción
Úlceras venosas crónicas	Principal complicación, difíciles de cicatrizar
Tromboflebitis superficial	Inflamación de venas varicosas
Eczema y dermatitis ocre	Pigmentación y prurito crónico
Lipodermatoesclerosis	Fibrosis cutánea progresiva
Celulitis recurrente	Por disfunción linfática asociada

Pronóstico:

- Generalmente benigno si se trata adecuadamente.
- Las úlceras venosas cicatrizan en 60–80% con compresión.
- Alta tasa de recurrencia si no se mantiene tratamiento compresivo.

7. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. **Síntoma cardinal:** pesadez y edema vespertino que mejora al elevar las piernas.
2. **Varices visibles + edema + cambios cutáneos = IVC.**
3. **Doppler venoso** confirma diagnóstico y plan quirúrgico.
4. **Tratamiento base:** compresión elástica + ejercicio.
5. **Safenectomía o ablación endovenosa** son curativas en varices sintomáticas.
6. **Úlceras venosas:** siempre compresión, nunca antisépticos.
7. **ITB <0,8 = contraindicación de compresión.**



Errores comunes

- Indicar antibióticos crónicos en úlceras sin infección.
- No descartar arteriopatía antes de compresión.
- Omitir Doppler preoperatorio.
- Confundir úlceras venosas con arteriales o neuropáticas.
- Tratar solo con fármacos sin medidas compresivas o posturales.

8. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **La IVC** es secundaria a reflujo o obstrucción venosa crónica → hipertensión venosa.

2. **Síntomas típicos:** pesadez, edema, prurito, hiperpigmentación y úlceras maleolares.
3. **Diagnóstico clínico + confirmación con Doppler venoso.**
4. **Tratamiento base:** compresión elástica, ejercicio y elevación de piernas.
5. **Cirugía o ablación endovenosa** en casos refractarios o estéticos.
6. **Úlcera venosa:** curas húmedas + compresión.
7. **Prevención:** control de peso, evitar ortostatismo prolongado y mantener actividad física.